

EPIDEMIOLOGIE

QCD

Q1. Dans la formule du calcul de la proportion, le numérateur se trouve dans le dénominateur.

Q2. Dans la formule du calcul du taux brut de natalité, le dénominateur est le nombre de femmes en âge de reproduction.

Q3. Dans la formule du calcul du taux de létalité, le dénominateur est le total de cas de décès.

Q4. L'accroissement annuel est la somme de la population d'arrivée plus la population de départ.

Q5. L'accroissement naturel tient compte des phénomènes migratoires.

Q6. L'incidence et la prévalence permettent de déterminer l'ampleur de la maladie dans une localité donnée.

Q7. L'indice est un rapport qu'on utilise lorsque le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur.

Q8. La létalité permet d'apprécier l'ampleur d'une maladie.

Q9. La létalité est le nombre de décès parmi les malades.

Q10. La létalité permet de déterminer la gravité de la maladie dans une localité donnée.

Q11. La létalité, est le nombre de décès causé par une maladie au cours d'une année.

Q12. La mortalité infantile se définit par le nombre de décès d'enfants dans la première année de la vie.

Q13. La mortalité juvénile est le décès qui survient entre 0 et 4 ans.

Q14. La période néonatale concerne les quatre semaines après la naissance.

Q15. La population des enfants de 0 à 11 mois est appelée population infantile.

Q16. La population des enfants de 0 à 4 ans est appelée population juvénile.

Q17. La population des enfants de 0 à 5 ans est appelée population infanto juvénile.

Q18. La prévalence indique la gravité d'un problème.

Q19. La prévalence indique l'ampleur d'un problème.

Q20. La projection de population permet d'obtenir la population exacte d'une localité.

Q21. La proportion est un rapport dans lequel le numérateur est inclus dans le dénominateur.

Q22. La proportion est un rapport dans lequel le numérateur et le dénominateur sont identiques.

Q23. La proportion est un rapport dont le dénominateur est inclus dans le numérateur.

Q24.Le dénominateur dans le calcul du taux de mortalité infantile est le nombre d'enfants âgé de 0 à 11 mois.

Q25.Le dénominateur dans le calcul du taux de mortalité maternelle est le nombre de femmes en âge de reproduction.

Q26.Le ratio est un rapport dans lequel le numérateur est inclus dans le dénominateur.

Q27.Le ratio est un rapport dans lequel le numérateur peut être supérieur au dénominateur.

Q28.Le ratio est un rapport qui ne comporte pas d'unité.

Q29.Le taux d'incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie enregistré dans une zone donnée au cours d'une période d'observation considérée.

Q30.Le taux d'incidence permet d'évaluer la qualité de la prévention d'une maladie.

Q31.Le taux d'incidence permet de mesurer la vitesse de propagation de la maladie.

Q32.Le taux de létalité permet d'évaluer la gravité de la maladie.

Q33.Le taux de létalité permet d'évaluer la prévention d'une maladie.

Q34.Le taux de létalité permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades.

Q35.Le taux de mortalité maternelle est une proportion.

Q36.Le taux général de fécondité(TGF) est un indicateur démographique.

Q37.Les décès influencent l'accroissement naturel.

Q38.Un accouchement assisté est un accouchement effectué par une personnel qualifié ou une personne formée à l'accouchement.

Q39.L'accroissement naturel d'une population prend en compte les naissances et les décès survenus dans la population ainsi l'immigration et l'émigration.

Q40.Le taux d'incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie enregistré dans une zone donnée, au cours d'une période d'observation considérée rapporté au total de cas de maladie de la même période.

Q41.Le taux brut de natalité est le nombre de naissances vivantes enregistré dans une zone donnée, au cours d'une période d'observation considérée rapporté à la population des femmes enceintes. A

Q42.Le numérateur dans le calcul du taux de mortalité infantile est le nombre d'enfants âgé de 0 à 11 mois révolu.

Q43.La mortalité juvénile est un indicateur de santé qui mesure le nombre de cas de maladie et de décès dans une population donnée.

Q44.Quand la situation morbide d'une période ne présente qu'une seule maladie, alors le Taux Brut de Mortalité (TBM) est égal au Taux de Létalité (TL).

Q45.Un accouchement est dit assisté lorsqu'il est effectué par une personne qualifiée ou un tradipraticien.

Q46.Un rapport en épidémiologie peut être : une proportion, un taux, un ratio ou un indice.

QCM

1. Parmi les indicateurs suivants, indiquez ceux qui sont à tendance positive

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| A. le taux de mortalité | B. le taux de natalité |
| C. le taux général de fécondité | D. le taux de morbidité |

2. Parmi les indicateurs de santé suivants, indiquez ceux qui sont à tendance négative

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A. le taux de prévalence | B. le taux de natalité |
| C. le taux de fécondité | D. le taux de morbidité |
| E. le taux de létalité | F. le taux de guérison |

3. Voici une liste d'indicateurs et des catégories

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Taux de prévalence | |
| 2. Taux d'incidence | a. Indicateurs à tendance positive |
| 3. Taux brut de natalité | b. Indicateurs à tendance négative |
| 4. Taux d'accouchement assisté | |
| 5. Taux de létalité | |
| 6. Taux général de fécondité | |
| 7. Taux d'accroissement naturel | |
| 8. Taux brut de morbidité | |
| 9. Taux de mortalité infantile | |

Identifiez les bonnes combinaisons entre les conséquences et les catégories

A (a,4 ;6 ;9 ;2) B (a,3 ;4 ;6 ;7) C (b,1 ;2 ;5 ;8 ;9) D (b ;1 ;3 ;4 ;5 ;9)

4. Voici une liste de tranches d'âge et des concepts

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 8 jours à moins de 28 jours | a. Mortalité néonatale |
| 2. 0 à 28 jours | b. Mortalité néonatal tardif |
| 3. 0 à moins de 8 jours | c. Mortalité post-néonatale |
| 4. 28 jours à 11 mois | d. Mortalité néonatale précoce |

Identifiez les bonnes combinaisons entre les tranches d'âge et les concepts

A (b,1) B (d,1) C (d,3) D (a ;2) E(b,3) F(a ;4)

5. Cocher l'indicateur de santé à tendance négative dans cette liste :

- A. Taux Brut de Natalité B. Taux d'accouchement assisté
C. Taux de prévalence D. Taux Général de Fécondité

Q1. Les enfants de 9 mois à 14 ans représentent :

- A. 4% de la population totale B. 5% de la population totale
C. 20% de la population totale D. 45% de la population totale

6. Le taux de mortalité maternelle (T.M.M.) se calcule avec comme dénominateur :

- A. le total des parturientes de l'année
B. le total des femmes en âge de reproduction de l'année
C. le total des décès maternel de l'année
D. le total des naissances vivantes de l'année

7. Le taux de mortalité néonatal tardif concerne :

- A. Les décès d'enfants de 0 à moins de 08 jours ;
B. Les décès d'enfants de 08 à moins de 28 jours
C. Les décès d'enfants de 28 jours à moins d'un an.

Q1. Au niveau des données démographiques, la proportion des enfants de 0 à 5 ans par rapport à la population totale est de :

- A. 4% B. 5% C. 17,32% D. 20%

Q2. Quelle est la proportion des enfants de 0 à 11 mois ?

- A. 20 % de la population totale B. 3.5 % de la population totale
C. 4,22 % de la population totale D. 3,5 % de la population totale

Q3. Quelle est la proportion des naissances attendues ?

- A. 20 % de la population totale B. 4.7 % de la population totale
C. 4,22 % de la population totale D. 05 % de la population totale

Q4. Quelle est la proportion des femmes en âge de reproduction ?

- A. 20 % de la population totale
- B. 3.5 % de la population totale
- C. 4,22 % de la population totale
- D. 05 % de la population totale

Q5. Voici une liste de tranches d'âge et des concepts

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 8 jours à moins de 28 jours | a. Mortalité néonatale |
| 2. 0 à 28 jours | b. mortalité néonatal tardif |
| 3. 0 à moins de 8 jours | c. mortalité post-néonatale |
| 4. 28 jours à 11 mois | d. mortalité neonatale précoce |

Identifiez les bonnes combinaisons entre les tranches d'âge et les concepts

A (b,1) B (d,1) C (d,3) D (a ;2) E(b,3) F(a ;4)

Q6. Le taux de mortalité néonatale tardif concerne :

- A. Les décès d'enfants de 0 à moins de 08 jours
- B. Les décès d'enfants de 08 à moins de 28 jours
- C. Les décès d'enfants de 28 jours à moins d'un an.

Q7. Voici une liste de tranches d'âge et des concepts

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 8 jours à moins de 28 jours | a. Mortalité néonatale |
| 2. 0 à 28 jours | b. mortalité néonatal tardif |
| 3. 0 à moins de 8 jours | c. mortalité post-néonatale |
| 4. 28 jours à 11 mois | d. mortalité neonatale précoce |

Identifiez les bonnes combinaisons entre les tranches d'âge et les concepts

A (b,1) B (d,1) C (d,3) D (a ;2) E(b,3) F(a ;4)

GESTION DES VACCINS

QCD

Q1. Au cours de la gestion des vaccins, la règle des 3PS permet d'éviter les doses sacrifiées.

Q2. Au cours de la gestion des vaccins, la règle PEPU permet d'éviter les doses gaspillées.

Q3. Dans le PEV, on parle de bonne gestion des stocks de vaccins lorsque le taux d'utilisation de vaccins est élevé.

Q4. Des doses perdues à cause de non qualification du vaccinateur sont des doses sacrifiées.

Q5. En cas de perte de doses au cours de la vaccination, le nombre de doses de vaccins utilisées est généralement supérieur au nombre de personnes vaccinées.

Q6. En Côte d'Ivoire les populations cibles des campagnes de VPO, de Td et de RR sont respectivement les enfants de 0 à 59 mois, les femmes en âge de reproduction et les enfants de 9 mois à 14 ans.

Q7. En Côte d'Ivoire les populations cibles du PEV d'un même antigène sont les mêmes selon qu'on soit en vaccination de routine ou en campagne de vaccination.

Q8. En Côte d'Ivoire, l'objectif vaccinal est identique en vaccination de campagne pour tous les vaccins.

Q9. En Côte d'Ivoire, l'objectif vaccinal est identique en vaccination de routine pour tous les vaccins.

Q10. En Côte d'Ivoire, l'objectif vaccinal varie uniquement selon l'activité vaccinale.

Q11. En Côte d'Ivoire, la méthode d'estimation des besoins en doses de vaccins et consommables la plus récente est celle basée sur la population cible.

Q12. Faire la vaccination en stratégie avancée est une solution pour réduire les populations hors de portée.

Q13. La commande des vaccins et consommables doit être précédée obligatoirement par l'inventaire de stock physique.

Q14. La pastille de contrôle de vaccin est un outil de gestion des stocks de vaccins.

Q15. La PCV est un cercle sensible à la chaleur placé à l'intérieur d'un carré qui change de couleur sous l'influence combinée de la chaleur et du froid.

Q16. La PCV permet de vérifier la péremption du vaccin.

Q17. La PCV permet de vérifier la viabilité du vaccin.

Q18. La politique des flacons entamés s'applique à tous les vaccins du PEV.

Q19. La Politique du flacon entamé consiste à réutiliser un flacon de vaccin ouvert et duquel l'on a prélevé une ou plusieurs doses de vaccins pour la prochaine séance de vaccination jusqu'à 4 semaines minimum.

Q20. La politique du flacon entamé ne s'applique qu'aux flacons multidoses liquides.

Q21. La quantité à commander est inscrite sur les fiches de stock des vaccins.

Q22. La quantité à commander est souvent égale au besoin réel.

Q23. La quantité des vaccins en stock est identifiable à partir des fiches de commande des vaccins.

Q24. La quantité des vaccins en stock est inscrite sur les fiches de stock.

Q25. La quantité en stock est inscrite dans le cahier d'inventaire des vaccins.

Q26. La sortie des vaccins du réfrigérateur se fait en fonction de la date de péremption et de la date de réception.

Q27. Le besoin réel des vaccins est inscrit sur les fiches de commande.

Q28. Le besoin théorique des vaccins et le stock de sécurité sont contenus dans le besoin réel.

Q29. Le besoin théorique des vaccins représente 25% du stock de sécurité.

Q30. Le besoin théorique est la quantité nette de vaccin équivalent à l'effectif de la population cible que l'on veut vacciner pendant une période donnée.

Q31. Le calcul du stock de sécurité dans l'estimation des besoins en vaccins et consommable se fait avec 25% pour les consommables et 10% pour les vaccins.

Q32. Le facteur de perte se calcule à partir du taux de perte ou du taux d'utilisation.

Q33. Le faible niveau de communication est une des causes des abandons vaccinaux.

Q34. Le faible taux de perte de vaccin est un indicateur de la qualité des services de vaccination.

Q35. Le nombre de contact vaccinal se détermine à partir du calendrier de vaccination en vigueur du PEV.

Q36. Le nombre de contacts vaccinaux annuels qu'il faut pour un sujet cible varie d'un vaccin à un autre.

Q37. Le nombre de seringues de dilution correspond au nombre de flacons de vaccins liquides à utiliser.

Q38. Le nombre de seringues de dilution correspond au nombre de flacons de vaccins lyophilisés.

Q39. Le non-respect de la politique du flacon entamé est un facteur évitable de perte de vaccins.

Q40. Le renforcement de la communication interpersonnelle et de la mobilisation sociale pour la vaccination est une stratégie de réduction des abandons vaccinaux.

- Q41. Le stock de sécurité des seringues est de 25% de leur besoin théorique.
- Q42. Le stock de sécurité des vaccins est de 25% de leur besoin réel.
- Q43. Le taux d'utilisation représente la proportion de vaccin sortie du stock et qui a été effectivement administrée à la cible.
- Q44. Le taux de couverture vaccinal global est l'effectif de la population cible correctement vacciné.
- Q45. Le taux de couverture vaccinal global est la proportion de la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de chaque antigène du PEV.
- Q46. Le taux de perte des seringues autobloquantes est 10%.
- Q47. Le taux de perte représente la proportion de vaccins sortie du stock et qui n'a pas été administrée à la cible.
- Q48. Le taux de perte de vaccin est un indicateur de la qualité des services de vaccination.
- Q49. Le vaccin BCG et le vaccin RR sont des vaccins sensibles à la lumière.
- Q50. Le vaccin contre le Papilloma Virus Humain est un vaccin sensible à la congélation.
- Q51. Les diluants des vaccins ne sont pas sensibles à la congélation.
- Q52. Les doses de vaccins consciemment perdues pour que la vaccination ait lieu sont considérées comme des doses sacrifiées.
- Q53. Les doses de vaccins perdues pour que la vaccination ait lieu sont considérées comme des doses sacrifiées.
- Q54. Les doses perdues doivent être prises en compte dans l'estimation des besoins en vaccins.
- Q55. Les doses perdues ne doivent pas être prises en compte dans l'estimation des besoins en vaccins.
- Q56. Les doses sacrifiées sont les doses de vaccins qu'on aura inconsciemment perdues pour que la vaccination ait lieu.
- Q57. Les facteurs inévitables de pertes de vaccins ne peuvent pas être améliorés.
- Q58. Les flacons de vaccin à reconstituer portent leur PCV sur le capuchon en plastique.
- Q59. Les flacons des vaccins liquides portent leur PCV sur l'étiquette du flacon.
- Q60. Les occasions manquées de vaccination constituent une des causes des abandons vaccinaux.
- Q61. Les règles PEPU et PPPS de gestion des vaccins sont identiques.
- Q62. Les seringues de dilution sont commandées seulement pour les vaccins lyophilisés.
- Q63. Les VAA, RR et BCG sont concernés par la politique du flacon entamé.

- Q64. Les vaccins lyophilisés sont sensibles à la congélation lorsqu'ils sont reconstitués.
- Q65. Les vaccins plus sensibles à la congélation sont reconnaissables par leurs flacons teintés en noir.
- Q66. Les vaccins sensibles à la congélation sont placés sur l'étagère du réfrigérateur près du freezer.
- Q67. Plus la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de vaccins de chaque antigène est élevée, moins le taux de couverture vaccinal global est élevé.
- Q68. Plus le taux de perte est élevé, moins le facteur de perte est bas.
- Q69. Plus le taux d'utilisation est élevé, moins le facteur de perte est élevé.
- Q70. Pour limiter le gaspillage de doses de vaccins il faut respecter les règles 2PS.
- Q71. Pour réduire le taux d'abandons, il faut rechercher activement les populations cibles non vaccinées.
- Q72. Pour une population totale de 15000 habitants en 2025, le nombre d'enfants de 0 à 23 mois et celui des femmes enceintes sont respectivement de 750 et 1023.
- Q73. S'assurer de la capacité de stockage de vaccin dans un centre vaccinal est l'une des précautions à prendre avant toute commande de vaccins.
- Q74. Un abandon vaccinal est toute cible qui, n'ayant jamais reçu de dose d'un vaccin donné refuse de poursuivre son calendrier de vaccination jusqu'à la fin.
- Q75. Un abandon vaccinal est toute cible qui, à un moment donné a utilisé les services de vaccination et qui, pour diverses raisons n'a pas poursuivi leur utilisation.
- Q76. Un cas d'abandon vaccinal est toute cible venue dans la structure sanitaire pour toute autre raison que la vaccination et qui sort de la structure sans être vaccinée.
- Q77. Un contact vaccinal est une dose d'un vaccin administrée à un sujet cible pour assurer sa protection.
- Q78. Un flacon à PCV virée constitue un flacon de doses gaspillées.
- Q79. Un taux d'utilisation de vaccins bas est un synonyme d'une bonne gestion des stocks de vaccins.
- Q80. Un vaccin doit être détruit si sur la pastille de contrôle du vaccin, le carré est plus clair que le cercle.
- Q81. Une boîte de sécurité utilisée pour la vaccination peut contenir en moyenne 120 seringues.

Q82. Une population ayant accès aux services de vaccination mais qui ne les utilisent pas pour des raisons d'ordres religieuse est dite hors d'accès.

Q83. Une population hors d'accès est constituée de personnes confrontées à des difficultés pour atteindre les services de vaccination.

Q84. Une population hors de portée a accès aux services de vaccination mais ne les utilisent pas.

Q85. Une population hors de portée est constituée de personnes qui n'ont aucun problème pour accéder physiquement au service de vaccination.

Q86. Une population ayant accès aux services de vaccination mais qui ne les utilisent pas pour des raisons d'ordres religieuse est une population hors d'accès.

Q87. Un enfant âgé de 2 semaines ayant reçu une dose de VPO et une dose de BCG est correctement vacciné.

Q88. Un enfant âgé de 2 semaines ayant déjà reçu le VPO0, le BCG et sa dose d'hépatite B à la naissance est correctement vacciné.

Q89. Un enfant correctement vacciné est celui qui reçoit toutes les doses de vaccins inscrites dans le programme élargi de vaccination.

Q90. Un enfant de 0 à 11 mois correctement vacciné reçoit trois doses d'hépatite B dans son organisme.

Q91. Un enfant de 8 mois ayant reçu toutes ses doses de vaccins à l'exception du RR et du VAA est correctement vacciné.

Q92. Un vaccin dont la PCV à virée et qui ne peut plus être utilisé est un vaccin sacrifié.

QCM

Q1. Le taux d'abandon du Penta varie:

A. en fonction du nombre de premières doses administrées à la population cible

B. en fonction du nombre de deuxièmes doses administrées à la population cible

C. en fonction du nombre de doses de premières doses et de deuxièmes doses administrées à la population cible

D. en fonction du nombre de troisièmes doses administrées à la population cible

Q2. Pour une population totale de 3000 habitants, la population cible de la campagne de Td est de :

A. 1350 femmes en âge de reproduction

B. 600 femmes en âge de reproduction

C. 150 femmes en âge de reproduction

Q3. Pour une population totale de 3000 habitants, la population cible de la campagne de RR est :

A-1350 enfants B-600 enfants C-120 enfants

Q4. Le taux d'abandon global varie

A. en fonction du nombre de doses de Penta1 administrées à la population cible
 B. en fonction du nombre de doses de RR1 administrées à la population cible
 C. en fonction du nombre de doses de Penta3 et de Penta 1 administrées à la population cible
 D. en fonction du nombre de doses de RR2 et de Penta 1 administrées à la population cible

Q5. Parmi les vaccins suivants, deux sont sensibles à la congélation. Lesquels ?

A-VPI B-VAA C-RR D-Td E-VPO

Q23. Pour une campagne de vaccination, l'objectif de couverture vaccinale en Côte d'Ivoire est de :

A-70% B-80% C-90% D-100%

Q6. Identifiez les vaccins du PEV auxquels s'applique la politique du flacon entamé

A-VPO B-RR C-BCG D-Td E-Penta F-VAA

Q7. Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de Td il réunir au moins :

A-16 femmes B-18 femmes C-15 femmes D-1 femme

Q8. Identifiez parmi les vaccins suivants, ceux qui sont éligibles au test d'agitation des anatoxines :

A-Penta B-VPO C-RR D-Td E-VPI

Q9. Un flacon de vaccin liquide déjà ouvert est réutilisable à condition :

A-qu'il ne soit pas périmé B-ait été contaminé
 C-n'ait pas été exposé excessivement au froid ou à la chaleur excessive ;
 D-ait été immergés dans de l'eau E-ne présente aucun trouble ou précipitation ;
 F-n'ait pas de PCV virée.

Q10. Identifiez les vaccins du PEV inéligibles à la politique du flacon entamé :

A-BCG B-VPO C-Td D-RR E-VAA F-Penta

Q11. Identifiez les vaccins qui peuvent être conservés pendant plus de 6 heures après l'ouverture du flacon :

A-VPO B-Td C-BCG D-RR E-VAA

Q12. Identifiez parmi les éléments suivants, ceux qui sont des causes de faibles taux de couverture :

A-la stratégie mobile B-les occasions manquées de vaccination C-les abandons vaccinaux
 D-la recherche active des cible

Q13. Parmi ces éléments, identifiez ceux qui constituent des causes d'abandon vaccinal

A-la stratégie avancée B-insuffisance de CCC C-le bon accueil
 D-la longue attente sur les lieux de vaccination
 E-la maîtrise des techniques vaccinales par le personnel de santé

Q14. Parmi ces éléments, identifiez ceux qui constituent des solutions aux abandons vaccinaux

- A. allonger le temps d'attente des mères sur les lieux de vaccination
- B. rechercher activement les cibles non vaccinées
- C. planifier les séances de vaccination adaptée aux activités socioculturelles des populations
- D. accentuer le mauvais accueil
- E. réduire les séances de CCC sur les activités de vaccination

Q15. Parmi les mesures suivantes, indiquez celles permettant de réduire les populations hors de portée:

- A- Intensifier la sensibilisation B- pratiquer la stratégie avancée C- résoudre les conflits
- D. promouvoir progressivement les considérations socioculturelles.
- E. pratiquer la vaccination par la stratégie du porte à porte

Q16. Parmi les facteurs suivants, identifier ceux qui sont évitables :

- A. Mauvaise gestion des stocks entraînant un approvisionnement excédentaire et la péremption des vaccins avant leur utilisation.
- B. L'utilisation d'autres vaccins dans lesquelles les conditions d'application de la politique d'utilisation des flacons multidoses entamés ne peuvent être réunies.
- C. Défaillance de la chaîne de froid exposant ainsi les vaccins à des températures extrêmement inacceptables (trop élevées ou trop basses).
- D. Vaccins reconstitués qui doivent être jetés à la fin de la séance.

Q17. Parmi les doses perdues suivantes, identifier celles qui constituent des doses sacrifiées.

- A- Les doses administrées à des populations hors cibles B- détérioration due à la congélation
- C- date de péremption passée, casses, vols etc. ;
- D- doses jetées avec les flacons de vaccins reconstitués

Q18. Quel est l'ordre des étapes à parcourir pour commander des vaccins

1. stock de sécurité
 2. besoin réel
 3. besoin théorique
 4. quantité à commander
 5. quantité en stock
- A. (1,2,3,4,5)
 - B. (5,3,4,2,1)
 - C. (3,1,2,5,4)
 - D. (4,5,2,1,3)

Q19. Parmi les vaccins suivants, identifiez ceux qui sont lyophilisés :

- A-BCG B-PCV-13 C-VPI D-RR E-VAA F-Rota G-Penta

Q20. Les éléments suivants sont à vérifier à la réception d'un stock de vaccins et de diluants sauf deux :

- A- le remplissage correcte des bordereaux de livraison B- la présence des bordereaux de livraison
- C- l'heure d'arrivée des colis au centre de santé D- le destinataire des colis
- E- la date de fabrication du vaccin

Q21. Les éléments suivants sont à vérifier à la réception d'un stock de vaccins et de diluants sauf un :

- A. L'aspect extérieur des colis
- B. la conformité du contenu des colis au bordereau de livraison
- C. le nombre d'accumulateurs utilisés pour assurer la chaîne du froid pendant le transport
- D. la conformité entre les vaccins et les diluants

Q22. Les éléments suivants sont à vérifier à la réception d'un stock de vaccins et de diluants sauf un :

- A. le respect des conditions de conservation des vaccins en matière d'emballage ;
- B. la couleur des accumulateurs ;
- C. l'état des PCV sur les flacons
- D. les dates de péremption des vaccins dans tous les colis

Q23. Les dispositions suivantes sont à prendre à la réception d'un stock de vaccins et de diluants sauf deux :

- A. signer le bon de livraison après avoir noté les problèmes constatés;
- B. signaler les incohérences au district sanitaire et garder les stock altérés
- C. Remplir correctement la fiche de stock de chaque antigène
- D. Ranger les diluants dans le réfrigérateur

Q24. Identifier parmi les éléments suivants, ceux qui influencent le rangement des vaccins dans un réfrigérateur :

- A-la lumière B-la sensibilité à la chaleur C-la sensibilité au bruit
- D-la sensibilité à la congélation. E-la sensibilité à la poussière

Q25. Parmi les vaccins suivants, identifier ceux qui sont sensibles à la lumière

- A-BCG B-Td C- RR D-VPI E- VPO

Q26. Parmi les vaccins suivants, identifier ceux qui sont sensibles à la congélation

- A-BCG B-Td C-RR D-VPI E-VPO

Q27. Parmi les vaccins suivants, identifier ceux qui sont sensibles à la congélation

- A.Penta B-PCV-13 C-Rotarix D-VPO E-BCG F-VAA

Q28. Dans un réfrigérateur horizontal, les vaccins suivants doivent être rangés au sommet sauf deux, lesquels :

- A-Penta B-RR C-VPO D-Td E-VPI

Q29. Parmi les éléments suivants, indiquez celles qui permettent de réduire les pertes de vaccins :

- A-les MAPI B-le relevé biquotidien de la température du réfrigérateur
- C-la politique du flacon entamé D-les occasions manquées E-la PCV
- F-les abandons vaccinaux

Q30. La PCV permet :

- A-d'éviter l'utilisation de vaccin conservé à une mauvaise température
- B-d'éviter l'utilisation d'un vaccin périmé
- C-de réduire les pertes évitables
- D-d'éviter l'utilisation d'un vaccin contaminé par des germes pathogènes
- E-d'éviter l'utilisation d'un vaccin contenant un dépôt trouble

Q31.Un vaccin ayant une PVC ne peut être utilisé lorsque :

- A. le carré intérieur est plus sombre que le cercle extérieur.
- B. le carré intérieur est plus clair que le cercle extérieur
- C. le carré intérieur s'obscurcit, mais est toujours plus clair que le cercle extérieur
- D. le carré intérieur prend la même couleur que le cercle extérieur
- E. le carré intérieur est moins clair que le cercle extérieur
- F. le carré intérieur est moins sombre que le cercle extérieur.

Q32.Les vaccins suivants sont inéligibles à la politique du flacon entamé sauf deux. Lesquels ?

- A-BCG B-VPO C-RR D-VAA E-Td

Q33.Les vaccins suivants sont éligibles à la politique du flacon entamé sauf deux. Lesquels ?

- A-BCG B-VPI C-RR D-Penta E-Td

Q34.Identifier parmi ces éléments, ceux qui peuvent favoriser l'augmentation du taux de couverture vaccinale :

- A.les occasions manquées de vaccination
- B-les stratégies avancées
- C-les populations hors de portée
- D-les populations hors d'accès
- E-la sensibilisation

Q35.Parmi les solutions suivantes, indiquez celles qui permettent de réduire les abandons vaccinaux :

- A-Intensifier les séances de CCC
- B-Augmenter le temps d'attente
- C-Améliorer l'accueil
- D-Former le personnel vaccinateur
- E-Augmenter les ruptures de vaccins
- F-Rechercher activement les populations cibles non vaccinées
- G.Planifier les séances de vaccination sans tenir compte des activités socioculturelles et économiques des populations.

Q36.Parmi les raisons suivantes identifier celles qui engendrent les populations hors de portée :

- A-les croyances religieuses
- B-l 'éloignement des structures de vaccination
- C-les conflits ethniques
- D-les raisons politiques
- E-les endroits difficiles d'accès

Q37.Parmi les solutions suivantes identifier celles qui permettent de réduire les populations hors de portée

- A-Pratiquer la stratégie avancée
- B- Résoudre les conflits interethniques
- C-Sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination
- D-Pratiquer la stratégie mobile
- E-Faire la vaccination en porte à porte

Q38.Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de VPO il réunir au moins :

- A-15 enfants de 0 à 11 mois
- B-18 enfants de 0 à 11 mois

C-16 enfants de 0 à 11 mois C-01 enfant de 0 à 11 mois

Q39.Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de RR il réunir au moins :

A-12 enfants de 0 à 11 mois B-17 enfants de 0 à 11 mois C-16 enfants de 0 à 11 mois

Q40.Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de Td il réunir au moins :

A-16 femmes enceintes B-1 femme enceinte C-15 femmes enceintes

Q41.Parmi les vaccins suivants, sélectionnez ceux qui sont administrés en Côte d'Ivoire à raison de plus de deux contacts :

A-Penta B-Rotarix C-VPI D-PCV13 E-VPO F-RR G-BCG

Q42.Selon les normes du PEV, pour ouvrir un flacon de 20 doses de BCG il faut réunir un minimum de :

A-12 enfants de 0 à 23 mois B-15 enfants de 0 à 23 mois C-18 enfants de 0 à 23 mois

Q43.Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de VPO il réunir au moins :

A-15 enfants de 0 à 23 mois B-18 enfants de 0 à 23 mois C-16 enfants de 0 à 23 mois
D-01 enfant de 0 à 23 mois

Q44.Parmi ces éléments, identifiez ceux qui constituent des solutions aux d'abandons vaccinaux

A.allonger le temps d'attente des mères sur les lieux de vaccination
B.rechercher activement les cibles non vaccinées
C.planifier les séances de vaccination adaptée aux activités socioculturelles des populations
D.Accentuer le mauvais accueil E-Intensifier la CCC

Q45.Parmi les règles suivantes de gestion des vaccins en vue de limiter les pertes, une seule est juste. Laquelle ?

A.la règle du PEPI B.la règle de 3PS C.la règle de SPPP

Q46.Dans un réfrigérateur vertical, les vaccins suivants doivent être rangés sur les étagères supérieures près du compartiment congélateur sauf deux, lesquels :

A.VAA B.VPI C.Penta D.RR E.BCG F.Td

Q47.Dans un réfrigérateur vertical, les vaccins suivants doivent être rangés sur les étagères supérieures près du compartiment congélateur sauf un, lequel:

A.VAA B.VPO C.VPI D.RR

Q48. Dans un réfrigérateur horizontal, les vaccins suivants doivent être rangés au sommet sauf deux, lesquels :

A. Penta B. RR C. VPO D. Td E. VPI

Q49. Les vaccins suivants sont éligibles à la politique du flacon entamé sauf deux. Lesquels ?

A. BCG B. VPI C. RR D. Penta E. Td

Q50. Indiquer parmi ces précautions celles qu'il faut prendre en compte pendant la sortie des vaccins du réfrigérateur.

A. tenir compte de la date de péremption du vaccin

B. tenir compte de la date de réception du vaccin

C. sortir en premier les vaccins dont le carré intérieur s'obscurcit, mais est encore plus clair que le cercle extérieur

D. sortir en dernier les vaccins utilisés et ramenés dans le cadre de la politique du flacon entamé

E. éviter d'exposer pendant longtemps les vaccins à la chaleur et au froid selon leur sensibilité

Q51. Identifier parmi ces éléments, ceux qui peuvent augmenter taux de couverture vaccinale :

A. les occasions manquées de vaccination B. les stratégies avancées

C. les populations hors de portée D. les populations hors d'accès E. la sensibilisation

Q52. Parmi les raisons suivantes identifier celles qui engendrent les populations hors d'accès :

A. les croyances religieuses B. l'éloignement des structures de vaccination

C. les conflits ethniques D. les raisons politiques E. les endroits difficiles d'accès

Q53. Parmi les solutions suivantes identifier celles qui permettent de réduire les populations hors d'accès :

A. Pratiquer la stratégie avancée B. Sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination

C. Résoudre les conflits interethniques C. Pratiquer la stratégie mobile

D. Faire la vaccination en porte à porte